HELP_Organi_P22 — Groupe E — Lots 242 à 246 — 20 questions

Questionnaire de recherche médicale pour l'encyclopédie PROFILES (examen fédéral suisse). Paquet 22 sur 30.

Consignes

1. Tu réponds de façon sourcée, jamais de mémoire. Sources suisses d'abord (OFSP, Swissmedic, AIPS sur swissmedicinfo.ch, Tox Info Suisse, Fedlex, ASSM, FMH, sociétés suisses), puis européennes (ESC, ERS, ERC, EASL, ESCMID, ESE, EULAR, EAACI, KDIGO, EMA). Jamais de recommandation exclusivement américaine.
2. Pour chaque question : recommandation suisse en vigueur (société ou autorité, titre, année, URL) ; version la plus récente comparée à la version citée dans le « Contexte », avec les différences ; informations, doses, posologies, voies et adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'AIPS, avec le numéro d'autorisation Swissmedic ; à défaut de source suisse, la recommandation européenne la plus récente.
3. Chaque réponse a sa propre source et son propre extrait mot pour mot, avec URL et date de consultation. Les formules « idem », « voir question X » ou une source recopiée sans extrait propre sont interdites.
4. Si aucune source fiable n'existe, écris « donnée non trouvée dans les sources consultées » et liste les sources consultées. N'invente jamais.
5. Au début, écris le nombre de questions reçues dans ce paquet. À la fin, rends exactement le même nombre de réponses, avec leurs numéros.
6. Fais ensuite auditer ce paquet par un agent distinct, en raisonnement élevé : URL existante, extrait présent dans la source, source suisse ou européenne la plus récente, dose conforme à l'AIPS. Il corrige ou marque « donnée non trouvée ». Il n'invente jamais.
7. Rends les réponses dans un Google Doc du dossier HELP nommé comme ce paquet, suivi de « _REPONSES ». Écris en français, en phrases verbales courtes.

Questions

E-045 — Moyenne — LOT 243 · SSP O7.21

Emplacement : LOT_243_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Partie 4 › DX.8 › complications de l'acupuncture (critères, 9.d deuxième intention, pneumothorax, biologie, prévention)

Contexte : Le cours cite une déclaration ERS sur le pneumothorax spontané primaire (traitement guidé par les symptômes) ; aucun critère formel des complications ni de recommandation d'imagerie de 2e intention.

Question : Quelle recommandation européenne la plus récente encadre la prise en charge du pneumothorax (ERS/EACTS/ESTS 2024 sur le pneumothorax spontané, BTS 2023 en comparaison) applicable au pneumothorax iatrogène après acupuncture ? Existe-t-il des standards suisses de sécurité de l'acupuncture (ASA, OFSP : hygiène, aiguilles à usage unique, déclaration) ? Citer la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL) ; comparer sa version la plus récente avec celle citée dans le cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :

6. Certitude et réserves :

E-057 — Haute — LOT 244 · SSP O7.22

Emplacement : LOT_244_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Partie 3 › DX.6 › tableau des statines (Simvastatin-Mepha®, Sortis®, Crestor®, Ezetrol®), plafonds selon l'interactant, rhabdomyolyse, réintroduction

Contexte : Le cours cite les FI suisses (simvastatine max 40 mg, atorvastatine max 80 mg, rosuvastatine contre-indiquée si ClCr < 30) ; traitement hospitalier de la rhabdomyolyse et intervalle de contrôle après réintroduction absents.

Question : Quels plafonds de dose des statines selon l'interactant (amiodarone, amlodipine, diltiazem, vérapamil, ciclosporine, macrolides, azolés, inhibiteurs de protéase, fibrates) fixent les FI suisses en vigueur ? Quelle conduite face aux symptômes musculaires sous statine (seuils de CK, arrêt, réintroduction, intervalle de contrôle) recommande l'EAS 2015/ESC-EAS 2019-2025, et quel traitement hospitalier de la rhabdomyolyse (hydratation : volume et cible de diurèse) recommande une source suisse ou européenne récente ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-061 — Haute — LOT 244 · SSP O7.22

Emplacement : LOT_244_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Partie 4 › DX.9 › hépatite médicamenteuse (flucloxacilline, imagerie, biopsie, moyens thérapeutiques, inscription en greffe, surveillance)

Contexte : Le cours suit EASL 2019 ; la flucloxacilline n'est pas vérifiée comme spécialité suisse ; spécialités et posologies des moyens (N-acétylcystéine, corticoïdes, acide ursodésoxycholique), critères d'inscription suisses et calendrier de surveillance absents.

Question : La flucloxacilline est-elle autorisée en Suisse (spécialité, titulaire) ? Quels traitements de la DILI recommandent l'EASL (version la plus récente) et une source suisse : N-acétylcystéine dans la DILI non paracétamol (dose), corticoïdes, acide ursodésoxycholique, cholestyramine ; indications de l'imagerie et de la biopsie ; calendrier de surveillance biologique ? Quels critères suisses d'inscription en urgence sur la liste de greffe hépatique (Swisstransplant, OTx-attribution) s'appliquent ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-062 — Haute — LOT 244 · SSP O7.22

Emplacement : LOT_244_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_244_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc 1 › scores DX.10 (SCORTEN, ALDEN) ; Partie 4 › DX.10 › toxidermies graves (RegiSCAR, médicaments à haut risque, organisation suisse, imputabilité, prévention allopurinol et lamotrigine, surveillance)

Contexte : Le cours suit le PNDS français 2017 ; items RegiSCAR, centre suisse de référence et numéro d'appel, statut suisse de la névirapine, des oxicams et des IPP, et surveillance biologique absents ; Lamictal® titration citée.

Question : Quelle structure suisse prend en charge le SJS/NET (centres des brûlés de Lausanne et Zurich, dermatologie universitaire : contact) et quelle recommandation européenne la plus récente (EADV/ERN-Skin, BAD 2016 mise à jour) encadre le diagnostic (SCORTEN, ALDEN, RegiSCAR) et le traitement (ciclosporine, IgIV, étanercept : dose) ? Quelles recommandations suisses ou européennes s'appliquent au génotypage HLA-B*58:01 avant allopurinol et HLA-B*15:02 avant carbamazépine, et quelles FI suisses de névirapine, d'oxicams et d'IPP mentionnent le risque de SCAR ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-048 — Moyenne — LOT 244 · SSP O7.22

Emplacement : LOT_244_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 1 › classifications (fenêtre « classification de l'Académie européenne d'allergologie », imputabilité), fenêtres « cinq centres régionaux de pharmacovigilance » et « matériels d'information »

Contexte : Le cours cite la classification EAACI (type VI sans détail), les catégories d'imputabilité OMS-UMC sans définitions, cinq CRPV (Bâle, Genève, Lausanne, Lugano, Zurich ; 1931 évaluations en 2024) et des matériels d'information exigés (rivaroxaban, valproate) sans liste complète.

Question : Quelles définitions exactes donnent la classification EAACI 2023 des réactions d'hypersensibilité (types I à VI) et le système d'imputabilité OMS-UMC (certain, probable, possible, improbable, conditionnel, inclassable) ? Quelle liste Swissmedic publie-t-elle des médicaments soumis à des matériels d'information de sécurité (mesures de minimisation des risques, URL) et quelle est la liste actuelle des centres régionaux de pharmacovigilance ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-049 — Moyenne — LOT 244 · SSP O7.22

Emplacement : LOT_244_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_244_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_244_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html ; LOT_244_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc 1 › point 2 (classement

DX.1–DX.3 sur Pirmohamed 2004) ; Partie 1 › fenêtre 2.3 « Suisse : ce que les chiffres… » ; Partie 2 › données suisses DX.3 ; Partie 3 › limites DX.6 et DX.7

Contexte : Le cours ordonne les DX sur des données britanniques de 2004 (hémorragie digestive 54 % des décès) ; le tableau de Beeler n'a pas été lu ; répartition suisse par classe et par entité (bradycardie, intoxication digitalique, myopathie, TdP) non trouvée.

Question : Quelle est la répartition suisse des admissions hospitalières pour effet indésirable médicamenteux par classe et par entité clinique (Beeler et al., données Swissmedic Vigilance-News, rapport annuel Swissmedic 2024–2025, OFS statistique médicale des hôpitaux) ? Quelles données européennes plus récentes que Pirmohamed 2004 existent ? Donner le chiffre suisse le plus récent (source, année, URL : OFS, OFSP, registre ou rapport national) ; à défaut, le chiffre européen le plus récent avec sa méthode de mesure.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-050 — Moyenne — LOT 244 · SSP O7.22

Emplacement : LOT_244_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html ; LOT_244_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Partie 2 › DX.4 (prévalence de l'étiquette « pénicilline »), DX.5 (fréquence suisse) ; Partie 4 › DX.8 (angio-œdème aux IEC), DX.9 (DILI), DX.10 (nécrolyse épidermique)

Contexte : Le cours dit que la prévalence suisse de l'étiquette d'allergie à la pénicilline et les fréquences suisses du syndrome sérotoninergique, de l'angio-œdème aux IEC, de la DILI (369 réactions hépatobiliaires en 2024) et de la nécrolyse épidermique sont non trouvées.

Question : Quels chiffres suisses récents existent pour la prévalence de l'étiquette « allergie à la pénicilline » chez l'adulte hospitalisé, l'incidence de l'angio-œdème sous IEC, l'incidence de la DILI et du SJS/NET (registre RegiSCAR, centres suisses), et le syndrome sérotoninergique (Tox Info Suisse) ? Donner le chiffre suisse le plus récent (source, année, URL : OFS, OFSP, registre ou rapport national) ; à défaut, le chiffre européen le plus récent avec sa méthode de mesure.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-060 — Moyenne — LOT 244 · SSP O7.22

Emplacement : LOT_244_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Partie 4 › DX.8 › interprétation des examens d'exclusion (C1-INH, tryptase) et tableau gold standard / première et deuxième intention

Contexte : Le cours dit que les valeurs normales, seuils et délais de prélèvement du C1-INH et de la tryptase sont absents ; enfant et grossesse non traités.

Question : Quels examens et seuils (C4, C1-INH protéine et fonction, tryptase sérique : délai de prélèvement) recommandent les recommandations européennes les plus récentes pour distinguer angio-œdème bradykinique médicamenteux, héréditaire, acquis et histaminique, y compris chez l'enfant et la femme enceinte ? Citer la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL) ; comparer sa version la plus récente avec celle citée dans le cours et

lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-063 — Haute — LOT 245 · SSP O7.23

Emplacement : LOT_245_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 1 › définition de l'UE (EMA) et fenêtre « l'OAMal art. 71a à 71d » [Appel A non déposé (filtre de sécurité) : réinjecter dans le fichier local]

Contexte : Le cours résume le règlement européen sur les médicaments orphelins via l'EMA et cite un abattement de prise en charge de 30 % ou 50 % selon les catégories de bénéfice, sans calcul détaillé.

Question : Quelle définition légale de la maladie rare et du médicament orphelin retiennent le droit suisse (LPTh art. 14 al. 1 let. f, OASMéd, statut de médicament orphelin Swissmedic) et le règlement (CE) n° 141/2000 ? Comment l'OAMal art. 71a–71d (révision entrée en vigueur le 1.1.2024) fixe-t-il les catégories de bénéfice, l'abattement de prix et la procédure de garantie de prise en charge ? Citer le texte suisse en vigueur (RS, article, alinéa, état du texte, URL) et, s'il y a lieu, les directives ASSM ou le Code de déontologie FMH applicables, avec leur année.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-067 — Haute — LOT 245 · SSP O7.23

Emplacement : LOT_245_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_245_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Bloc 2 › tableau thérapeutique DX.1 Myasthénie (eculizumab, ravulizumab, zilucoplan, efgartigimod, rozanolixizumab) ; Partie 1 › DX.1 › alternatives (grossesse : imagerie du thymus) [Appel A non déposé (filtre de sécurité) : réinjecter dans le fichier local]

Contexte : Le cours cite les schémas posologiques par poids et la vaccination antiméningococcique ; adaptations rénales, hépatiques, pédiatriques et en grossesse absentes ; IRM thoracique préférée en grossesse par équivalence avec la TDM.

Question : Quels médicaments de la myasthénie généralisée sont autorisés en Suisse (Soliris®, Ultomiris®, Zilbrysq®, Vyvgart®, Rystiggo®, nipocalimab), avec indication exacte, limitation de la Liste des spécialités et garantie de prise en charge ? Quelle recommandation suisse (Société suisse de neurologie) ou européenne la plus récente (EAN 2025, guidelines allemandes DGN 2025) fixe leur place, et quelle conduite pendant la grossesse (imagerie, traitements contre-indiqués) ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :

2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-069 — Haute — LOT 245 · SSP O7.23

Emplacement : LOT_245_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_245_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc 2 › tableau thérapeutique DX.3 (Alyftrek®) ; Partie 2 › DX.3 › tableau d'interprétation (ALAT/ASAT sous modulateur), 7.3 syndrome hépatique, surveillance (ophtalmologie), thérapie génique

Contexte : Le cours cite Alyftrek® (≥ 40 kg : 2 comprimés 10/50/125 mg) et l'arrêt si ALAT/ASAT > 5 × LSN ; statut Swissmedic, adaptations et surveillance radiologique absents.

Question : Quels modulateurs du CFTR sont autorisés en Suisse (Kaftrio®/Kalydeco®, Alyftrek®, Orkambi®, Symkevi®) avec indications par génotype et âge, limitations de la Liste des spécialités et adaptations hépatiques (Child-Pugh) et rénales ; quel calendrier de surveillance (transaminases, ophtalmologie chez l'enfant) recommandent les FI suisses et les standards ECFS 2024 ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-071 — Haute — LOT 245 · SSP O7.23

Emplacement : LOT_245_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Partie 2 › DX.3 et DX.5 › fenêtres « infirmité congénitale OIC 480 » et « infirmité congénitale OIC 456 »

Contexte : Le cours attribue la mucoviscidose à l'OIC 480 et la maladie de Wilson à l'OIC 456, prise en charge AI jusqu'à 20 ans (LAI art. 13) ; autres exceptions absentes.

Question : Vérifier dans l'annexe de l'OIC-DFI (RS 831.232.211, état en vigueur après la révision du 1.1.2022) les numéros et libellés exacts de la mucoviscidose et de la maladie de Wilson (et de la drépanocytose) ; quelles conditions, quelle procédure d'annonce à l'office AI et quelles exceptions s'appliquent ? Citer le texte suisse en vigueur (RS, article, alinéa, état du texte, URL) et, s'il y a lieu, les directives ASSM ou le Code de déontologie FMH applicables, avec leur année.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-074 — Haute — LOT 245 · SSP O7.23

Emplacement : LOT_245_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_245_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc 2 › tableau thérapeutique DX.4 (Casgevy®) ; Partie 2 › DX.4 › crizanlizumab et voxelotor

Contexte : Le cours cite Casgevy® (dose minimale 3 × 10^6 CD34+/kg) ; FI suisses du crizanlizumab et du voxelotor absentes d'AIPS.

Question : Quel est le statut Swissmedic actuel de Casgevy® (exagamglogène autotemcel), de Lyfgenia®, du crizanlizumab (Adakveo®) et du voxelotor (Oxbryta®, retiré du marché mondial en septembre 2024) ? Préciser les indications autorisées et la prise en charge en Suisse. Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-075 — Haute — LOT 245 · SSP O7.23

Emplacement : LOT_245_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Partie 2 › DX.4 › fenêtre « dépistage néonatal universel remboursé », Doppler transcrânien annuel (170–199 cm/s : délai de contrôle), surveillance après Casgevy®

Contexte : Le cours dit que la drépanocytose ne figure pas dans le dépistage néonatal suisse ; recommandations suisses sur le dépistage ciblé et délai de contrôle en zone conditionnelle du Doppler absents.

Question : La drépanocytose fait-elle partie du dépistage néonatal suisse en 2026 (Laboratoire suisse de dépistage néonatal, Zurich, liste des maladies) ? Quelle recommandation suisse de dépistage ciblé existe ? Quel délai de contrôle du Doppler transcrânien en zone conditionnelle (170–199 cm/s) et quel calendrier de surveillance biologique après thérapie génique recommandent les guidelines les plus récentes (STOP, ASH 2020, EHA) ? Citer la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL) ; comparer sa version la plus récente avec celle citée dans le cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-077 — Haute — LOT 245 · SSP O7.23

Emplacement : LOT_245_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Partie 2 › DX.5 › fenêtre « insuffisance hépatique aiguë avec bilirubine… », tableau (phosphatases alcalines), diagnostic différentiel hétérozygote ATP7B, fenêtre « New Wilson Index »

Contexte : Le cours dit que les rapports chiffrés (PAL/bilirubine, ASAT/ALAT) et les composantes du New Wilson Index (≥ 11 : décès sans greffe) ne figurent pas dans les sources lues.

Question : Quels critères biologiques de la forme fulminante de la maladie de Wilson (rapport PAL/bilirubine totale < 4, rapport ASAT/ALAT > 2,2) et quelles composantes et seuils du New Wilson Index (Dhawan) retiennent les recommandations EASL-ERN 2025 ? Quand transférer en centre de greffe hépatique suisse ? Citer la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL) ; comparer sa version la plus récente avec celle citée dans le cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-078 — Haute — LOT 245 · SSP O7.23

Emplacement : LOT_245_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 2 › tableau thérapeutique DX.6 (Berinert® crise et prophylaxie, Firazyr®, Takhzyro®, Andembry®) [Appel A non déposé (filtre de sécurité) : réinjecter dans le fichier local]

Contexte : Le cours cite Berinert® 20 UI/kg i.v., Firazyr® 30 mg s.c., Takhzyro® 300 mg toutes les 2 semaines, Andembry® 400 mg puis 200 mg/mois ; adaptations rénales, hépatiques, pédiatriques et grossesse absentes.

Question : Quels traitements de l'angio-œdème héréditaire sont autorisés en Suisse (Berinert®, Cinryze®, Ruconest®, Firazyr®, Takhzyro®, Orladeyo®, Andembry®, sebetralstat) avec indication, âge, dose, adaptations et usage en grossesse ? Quelle place leur donne la recommandation WAO/EAACI la plus récente (2025) et quel plan d'urgence suisse existe (HAE Suisse, centres) ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-079 — Haute — LOT 245 · SSP O7.23

Emplacement : LOT_245_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 2 › tableau thérapeutique DX.7 Maladie de Fabry (Elfabrio®) [Appel A non déposé (filtre de sécurité) : réinjecter dans le fichier local]

Contexte : Le cours cite pégunigalsidase alfa 1 mg/kg toutes les 2 semaines ou 2 mg/kg toutes les 4 semaines ; adaptations absentes ; autres traitements non listés.

Question : Quels traitements de la maladie de Fabry sont autorisés en Suisse (agalsidase alfa Replagal®, agalsidase bêta Fabrazyme®, pégunigalsidase alfa Elfabrio®, migalastat Galafold®) avec indication, dose, adaptations rénale et en grossesse, et critères de début selon la recommandation européenne la plus récente (ERN, consensus 2023) ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :

6. Certitude et réserves :

E-080 — Haute — LOT 245 · SSP O7.23

Emplacement : LOT_245_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 2 › tableau thérapeutique DX.8 HPN (Soliris®, Ultomiris®, Fabhalta®, Aspaveli®, Voydeya®) [Appel A non déposé (filtre de sécurité) : réinjecter dans le fichier local]

Contexte : Le cours cite les schémas d'eculizumab, ravulizumab, iptacopan, pegcétacoplan et danicopan ; adaptations rénales, hépatiques et en grossesse absentes.

Question : Quels traitements de l'HPN sont autorisés en Suisse avec leur indication exacte (première ligne, relais), dose, adaptations, conduite en grossesse et vaccination exigée (méningocoque ACWY et B, pneumocoque, Haemophilus) selon les FI suisses ? Quelle recommandation européenne la plus récente fixe leur ordre d'emploi (crovalimab inclus) ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-081 — Haute — LOT 245 · SSP O7.23

Emplacement : LOT_245_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 2 › tableau thérapeutique DX.9 Amylose à transthyrétine (Amvuttra®, Onpattro®) [Appel A non déposé (filtre de sécurité) : réinjecter dans le fichier local]

Contexte : Le cours cite vutrisiran 25 mg s.c. tous les 3 mois et patisiran 300 µg/kg i.v. toutes les 3 semaines avec vitamine A ; tafamidis et acoramidis non listés ; adaptations absentes.

Question : Quels traitements de l'amylose ATTR sont autorisés en Suisse (tafamidis Vyndaqel®/Vyndamax®, acoramidis, vutrisiran, patisiran, inotersen, éplontersen) pour la cardiomyopathie et pour la polyneuropathie, avec dose, limitations de la Liste des spécialités et adaptations ? Quelle place leur donne l'ESC (cardiomyopathies 2023) ou la recommandation européenne la plus récente ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-082 — Haute — LOT 245 · SSP O7.23

Emplacement : LOT_245_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 1 › diagnostic différentiel DX.10 ; Bloc 2 › tableau thérapeutique DX.10 Porphyrie aiguë intermittente (Normosang®, glucose 10 %) [Appel A non déposé (filtre de sécurité) : réinjecter dans le fichier local]

Contexte : Le cours cite hémine 3 mg/kg/j i.v. pendant 4 jours (max 250 mg/j) et glucose 300–500 g/j ; adaptations et givosiran non listés.

Question : Quelle prise en charge de la crise de porphyrie hépatique aiguë recommandent le centre suisse des porphyries (Triemli Zurich) ou l'European Porphyria Network (EPNET) : hémine (FI suisse de Normosang®), glucose, liste des médicaments sûrs (base suisse ou drugs-porphyria.org), givosiran (Givlaari® : statut Swissmedic, dose, indication prophylactique) ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

FIN DU PAQUET HELP_Organi_P22 — 20 questions : E-045, E-057, E-061, E-062, E-048, E-049, E-050, E-060, E-063, E-067, E-069, E-071, E-074, E-075, E-077, E-078, E-079, E-080, E-081, E-082